Plan de Comunicaciones del Proyecto de Arquitectura Empresarial del Hospital de Tingo María: Estrategia para el Involucramiento de los Interesados

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	15/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial: objetivos, principios, canales, interesados, mensajes, matriz y calendario de comunicación.
2.0	20/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Revisión conforme al contenido típico del Plan de Comunicaciones en TOGAF 9.1: se agrupan los 18 interesados por necesidad de comunicación; se vinculan los mensajes clave con la Visión y sus indicadores; se añaden lugares, matriz entregable por grupo, calendario por semanas e hitos, factores críticos de éxito, indicadores de efectividad, protocolo para mensajes sensibles y riesgos con nivel inicial y residual. Se corrigen los canales dirigidos a pacientes y se alinea el calendario con A-01 y A-02.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Plan de Comunicaciones (*Communications Plan*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión	2.0 (borrador para aprobación)
Fecha de la versión	20/10/2026
Revisado y aprobado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha prevista de aprobación	Semana 7

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Architecture Review Board (ARB)	Aprobar	Semana 7	Sesión del ARB
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Informar	Semana 7	Correo institucional
Dirección Asistencial	Revisar los canales y horarios para el personal clínico	Semana 5	Correo institucional
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar la disponibilidad de los canales digitales	Semana 5	Correo institucional
Oficina de Recursos Humanos	Revisar la coordinación con capacitación	Semana 5	Correo institucional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informar	Semana 7	Correo institucional

Resumen

El Plan de Comunicaciones define cómo, cuándo, dónde y por qué medio el proyecto de arquitectura empresarial del Hospital de Tingo María se comunicará con cada uno de sus interesados. Su finalidad es que las personas que deben aprobar, validar, usar u operar la futura arquitectura reciban la información que necesitan en el momento oportuno, y que sus preocupaciones regresen al proyecto como requisitos o decisiones registradas. Los dieciocho interesados identificados en la Visión de la Arquitectura se organizan en siete grupos según sus necesidades de comunicación: gobierno, usuarios clínicos, usuarios administrativos y de soporte, operación tecnológica, entes sectoriales, pacientes y comunidad, y proveedores. Para cada grupo se formulan mensajes clave vinculados con la visión y sus indicadores, evitando promesas que la arquitectura no pueda cumplir. El plan establece los canales y lugares de comunicación, una matriz de comunicaciones con responsables y frecuencias, la distribución de cada entregable por grupo, un calendario de 24 semanas sincronizado con los hitos de la Declaración de Trabajo y un procedimiento de retroalimentación conectado con la gestión de requisitos y de cambios. Además, define factores críticos de éxito, indicadores para medir la efectividad de la comunicación, un protocolo para mensajes sensibles y los riesgos de comunicación con su nivel inicial y residual.

Palabras clave: TOGAF 9.1, plan de comunicaciones, gestión de interesados, arquitectura empresarial, hospital público, gestión del cambio

Contenido

Resumen **2**
1. Introducción **4**
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Contenido mínimo según TOGAF 4
1.3 Entradas y salidas 4
2. Objetivos y principios de comunicación **5**
2.1 Objetivos 5
2.2 Principios 5
3. Grupos de interesados y necesidades de comunicación **5**
3.1 Agrupación por necesidad de comunicación 5
3.2 Necesidades de información por grupo 6
4. Mensajes clave vinculados con la Visión de la Arquitectura **6**
4.1 Mensaje central 7
4.2 Mensajes por grupo 7
5. Mecanismos, canales y lugares de comunicación **8**
5.1 Canales 8
5.2 Accesibilidad de la comunicación 8
6. Matriz de comunicaciones **9**
7. Distribución de entregables por grupo de interesados **10**
8. Calendario de comunicaciones **11**
9. Retroalimentación y gestión de preocupaciones **12**
9.1 Vías de entrada 12
9.2 Procedimiento 13
10. Protocolo para mensajes sensibles **14**
11. Factores críticos de éxito e indicadores de efectividad **14**
11.1 Factores críticos de éxito 14
11.2 Indicadores de efectividad 15
12. Roles y responsabilidades de comunicación **15**
13. Riesgos de comunicación **16**
14. Supuestos y restricciones **17**
14.1 Supuestos 17
14.2 Restricciones 17
15. Conclusiones **17**
16. Referencias **18**
17. Apéndices **19**
Apéndice A. Siglas 19
Apéndice B. Modelo de acta de sesión 19
Apéndice C. Modelo de encuesta breve para pacientes 19
18. Hoja de control de aprobaciones **20**

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

TOGAF 9.1 señala que la arquitectura empresarial solo tiene valor si los interesados la entienden, la aceptan y la usan, y que para lograrlo es necesario planificar la comunicación con ellos desde la Fase A (The Open Group, 2011, cap. 24). El Plan de Comunicaciones es el entregable que asegura esa planificación: identifica a quién hay que comunicar, qué mensaje, por qué medio y en qué momento (Josey, 2011).

En el Hospital de Tingo María la comunicación tiene un peso especial por tres motivos. Primero, el personal clínico, cuya validación es indispensable, trabaja con una carga asistencial alta y poco tiempo disponible. Segundo, el cambio hacia un expediente electrónico puede generar temores (más trabajo, control, reemplazo de personal) que, si no se atienden, se convierten en resistencia. Tercero, parte de la arquitectura depende de entes externos, como la DIRESA Huánuco, el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud, que se comunican por vías formales y con plazos propios.

1.2 Contenido mínimo según TOGAF

Tabla 4
Correspondencia entre el contenido típico de TOGAF y las secciones del documento

Contenido típico del Plan de Comunicaciones (TOGAF 9.1)	Sección
Identificación de los interesados y su agrupación según requisitos de comunicación	3
Identificación de necesidades de comunicación, mensajes clave en relación con la Visión de la Arquitectura, riesgos de comunicación y factores críticos de éxito	3, 4, 11 y 13
Identificación de los mecanismos que se usarán para comunicarse con los interesados y darles acceso a la información de arquitectura (reuniones, boletines, repositorios, etc.)	5 y 6
Calendario de comunicaciones: qué comunicaciones ocurren, con qué grupos, en qué momento y en qué lugar	7 y 8

Nota. Adaptado de *TOGAF Version 9.1* (cap. 36), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing.

1.3 Entradas y salidas

Tabla 5
Ubicación del documento en el ciclo ADM

Tipo	Elemento
Se produce en	Fase A (paso 2: identificar interesados, preocupaciones y requisitos)
Entradas principales	Catálogo de interesados y matriz poder/interés (A-01, sección 7); cronograma e hitos (A-02, sección 12); estructura de gobierno (A-02, sección 4)
Se utiliza en	Todas las fases del ADM (A a H) y en la Gestión de Requisitos
Se actualiza	Al cierre de cada fase, o cuando cambien los interesados o el cronograma

2. Objetivos y principios de comunicación

2.1 Objetivos

1. **Lograr la aprobación oportuna** de los entregables en cada hito (H1 a H8) por parte del patrocinador y del ARB.
2. **Obtener la validación del personal clínico** sobre los procesos y requisitos, en especial del escenario de consulta externa (EB-01).
3. **Reducir la incertidumbre y la resistencia** explicando qué cambiará, qué no cambiará y cómo se protegerá a pacientes y trabajadores.
4. **Coordinar formalmente con los entes sectoriales** los requisitos de interoperabilidad y reporte.
5. **Convertir las preocupaciones en requisitos o decisiones registradas**, de modo que ninguna observación se pierda.

2.2 Principios

Tabla 6
Principios de comunicación del proyecto

Principio	Qué significa en la práctica
Oportunidad	Las convocatorias se envían con al menos cinco días hábiles de anticipación y los documentos a revisar con una semana.
Claridad	Cada comunicación usa el lenguaje de su audiencia: técnico con la OSI, de gestión con la Dirección, sencillo y sin siglas con el personal y los pacientes.
Honestidad	No se promete lo que la arquitectura no puede garantizar; se comunican también los riesgos y los plazos reales.
Doble vía	Toda comunicación relevante ofrece una forma de responder, preguntar u observar.
Consistencia	Los mensajes son coherentes entre canales y con los entregables aprobados; la fuente única es el Repositorio de Arquitectura.
Trazabilidad	Las comunicaciones formales y la retroalimentación se registran con fecha, autor, audiencia y respuesta.
Confidencialidad	Ninguna comunicación incluye datos personales de pacientes ni información presupuestal reservada en canales abiertos (principio PA-04).
Respeto por la atención	Las actividades con personal clínico se programan fuera de las horas de mayor demanda y nunca interrumpen la atención (principio PA-02).

3. Grupos de interesados y necesidades de comunicación

3.1 Agrupación por necesidad de comunicación

TOGAF recomienda agrupar a los interesados según lo que necesitan saber y cómo prefieren recibirlo, porque comunicar a dieciocho interesados por separado es ineficiente (The Open Group, 2011, cap. 24). Los interesados del catálogo de la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 18) se organizan en siete grupos.

Tabla 7
Grupos de comunicación y su composición

Grupo	Interesados	Cuadrante poder/interés	Nivel de involucramiento
G1. Gobierno y decisión	INT-06 Dirección Ejecutiva; INT-07 Dirección Asistencial; INT-08 Dirección de Administración; INT-09 Planeamiento y Presupuesto	Actores clave y mantener satisfechos	Aprobar y decidir
G2. Usuarios clínicos	INT-02 Personal médico; INT-03 Personal de enfermería; INT-04 Personal de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Actores clave y mantener informados	Consultar y validar
G3. Usuarios administrativos y de soporte	INT-05 Personal administrativo; INT-11 Recursos Humanos	Mantener informados y monitorear	Informar, consultar y capacitar
G4. Operación tecnológica	INT-10 Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Mantener informados	Colaborar y revisar
G5. Entes sectoriales y supervisores	INT-12 DIRESA Huánuco; INT-13 Gobierno Regional de Huánuco; INT-14 MINSA; INT-15 SIS; INT-16 SUSALUD	Mantener satisfechos y monitorear	Coordinar e informar
G6. Pacientes y comunidad	INT-01 Pacientes, familiares y comunidad usuaria	Mantener informados	Informar y escuchar
G7. Proveedores	INT-17 Proveedor del sistema actual; INT-18 Otros proveedores tecnológicos	Mantener informados y monitorear	Informar y solicitar información

3.2 Necesidades de información por grupo

Tabla 8
Necesidades de información, preocupaciones y formato preferido por grupo

Grupo	Qué necesita saber	Preocupación principal	Formato preferido
G1	Avance contra el plan, decisiones pendientes, riesgos, costos y cumplimiento normativo	Uso del presupuesto, cumplimiento legal, imagen institucional	Resumen ejecutivo de una página y sesión presencial
G2	Cómo cambiará su trabajo diario; cuándo y cómo participarán; cómo se protegerá la atención	Carga adicional de registro, disponibilidad del sistema, confidencialidad	Sesiones cortas de trabajo, demostraciones con casos reales, mensajes breves
G3	Qué trámites se simplificarán; qué capacitación recibirán y cuándo	Cambios en funciones y estabilidad laboral	Charlas breves, comunicados internos, sesiones de capacitación
G4	Arquitectura de datos, aplicaciones y tecnología; inventarios; requisitos de operación	Carga de trabajo, capacidades técnicas, dependencia de proveedores	Documentos técnicos, talleres, Repositorio
G5	Requisitos de interoperabilidad y reporte; alineamiento normativo	Cumplimiento de estándares sectoriales	Oficios institucionales y reuniones técnicas
G6	Qué mejorará en su atención y cuándo; cómo se protegen sus datos	Tiempo de espera, trato y privacidad	Afiches en salas de espera, avisos verbales, encuestas breves
G7	Qué información se les solicitará; cómo afectará la arquitectura a sus contratos	Continuidad contractual	Comunicaciones formales por escrito

4. Mensajes clave vinculados con la Visión de la Arquitectura

Los mensajes clave traducen la Visión de la Arquitectura (A-01) al lenguaje de cada grupo. La versión 1.0 contenía promesas generales, como "los sistemas serán fáciles de usar", que no podían verificarse. En esta versión cada mensaje se apoya en un objetivo o

indicador de la visión y se acompaña de lo que *no* debe prometerse, para proteger la credibilidad del proyecto.

4.1 Mensaje central

> El Hospital de Tingo María está construyendo, paso a paso y sin detener la atención, un expediente clínico electrónico único para que cada paciente sea atendido con su información completa, en menos tiempo y con sus datos protegidos.

4.2 Mensajes por grupo

Tabla 9
Mensajes clave por grupo de comunicación

Grupo	Mensaje clave	Sustento en la Visión	Lo que no se debe prometer
G1	"La arquitectura nos permite invertir por etapas, cumplir la normativa de historia clínica electrónica y protección de datos, y medir resultados con siete indicadores."	OA-01 a OA-07; KPI-01 a KPI-07	Montos de implementación antes de las Fases E y F
G2	"El objetivo es que vean toda la historia del paciente en una sola pantalla y registren una sola vez. Ustedes validan cada proceso antes de que se apruebe."	OA-01; RQ-01; escenario EB-01; principio PA-05	Fechas de implantación del sistema o un producto específico
G3	"El paciente se registrará una sola vez y se reducirán los trámites repetidos. Recibirán capacitación antes de cualquier cambio."	OA-02; OA-06; RQ-02	Que no habrá ningún cambio en sus funciones
G4	"La arquitectura ordenará el portafolio, reducirá soluciones aisladas y la dependencia de un solo proveedor. La OSI participa en cada decisión técnica."	Brechas BR-04 y BR-06; principios PA-06 y PA-07	Más personal o equipamiento antes de la Fase F
G5	"El hospital alineará su historia clínica electrónica con el RENHICE y usará estándares abiertos para intercambiar información con el sector."	OA-04; restricción CN-A-05	Fechas de interfaces que dependen de decisiones sectoriales
G6	"Estamos trabajando para que su atención sea más rápida y su información esté siempre protegida. Su opinión nos ayuda a mejorar."	OA-02; OA-03	Reducciones concretas de tiempo antes de medir la línea base
G7	"El hospital está documentando su arquitectura. Les solicitaremos información técnica y los requisitos futuros se comunicarán por canales formales."	Principio PA-06	Continuidad o término de contratos

5. Mecanismos, canales y lugares de comunicación

5.1 Canales

Tabla 10
Canales de comunicación, uso y lugar

Canal	Uso principal	Grupos	Lugar o medio
Sesión del ARB	Revisión y aprobación de entregables; decisiones de cambio	G1	Sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva (presencial; virtual si no hay quórum presencial)
Reunión del Comité de Seguimiento	Avance semanal, riesgos y preparación de la agenda del ARB	Equipo, enlaces	Oficina del equipo de arquitectura
Sesión de trabajo con áreas	Levantamiento y validación de procesos y requisitos	G2, G3, G4	En el servicio correspondiente (consultorios, laboratorio, farmacia) para no desplazar al personal
Taller de validación	Validación del escenario EB-01 y de procesos objetivo	G1, G2	Auditorio del hospital
Boletín interno "Avanzamos"	Avance del proyecto en lenguaje sencillo, una página	G2, G3, G4	Correo institucional, intranet y periódico mural
Correo institucional	Convocatorias, envío de documentos, notificaciones	Todos los internos, G7	Cuenta del proyecto: architecture@hospitaltingomaria.gob.pe
Intranet institucional	Publicación de comunicados y entregables no sensibles	G1 a G4	Sección del proyecto en la intranet
Repositorio de Arquitectura	Fuente única y oficial de entregables aprobados	G1, G4 y equipo	Servidor institucional con acceso por rol
Oficio institucional	Comunicación formal con entes externos	G5, G7	Mesa de partes y mesa de partes digital
Reunión técnica sectorial	Coordinación de interoperabilidad y reporte	G5, G4	Sede de la DIRESA Huánuco o videoconferencia
Afiches y avisos en salas de espera	Información a pacientes y familiares	G6	Salas de espera de consulta externa, admisión y farmacia
Encuesta breve de satisfacción	Recoger la percepción de los pacientes sobre tiempos y trato	G6	Admisión y consultorios, en papel o con código QR
Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones	Canal permanente de opinión de los usuarios	G6	Admisión del hospital

Nota. En la versión 1.0 se indicaba que los pacientes serían informados por la intranet; se corrige porque los pacientes no tienen acceso a ella. Las encuestas a pacientes son anónimas y no registran datos de identificación.

5.2 Accesibilidad de la comunicación

1. Los mensajes al personal y a los pacientes usan frases cortas, sin siglas técnicas y con ejemplos de la atención diaria.
2. Los afiches combinan texto breve con íconos, para personas con poca familiaridad con la lectura.
3. Las sesiones con el personal clínico duran como máximo 45 minutos y se programan en horarios acordados con cada jefatura.
4. Toda comunicación oral importante se respalda con un documento breve o un acta.

6. Matriz de comunicaciones

Tabla 11

Matriz de comunicaciones del proyecto

Código	Comunicación	Contenido	Audiencia	Frecuencia	Formato	Canal	Responsable
COM-01	Lanzamiento del proyecto	Propósito, alcance, beneficios esperados, cómo participar	Todos los grupos internos	Una vez (semana 2)	Comunicado oficial y reunión	Auditorio, correo, intranet, mural	Patrocinador y arquitecto líder
COM-02	Sesión del ARB	Entregables, decisiones, cambios, riesgos	G1	Quincenal	Orden del día y acta	Sesión del ARB	Secretario del ARB
COM-03	Reunión del Comité de Seguimiento	Avance, bloqueos, riesgos	Equipo y enlaces	Semanal (30 minutos)	Lista de acuerdos	Reunión	Arquitecto líder
COM-04	Informe mensual de avance	Avance contra el plan, riesgos, cambios, decisiones pendientes	G1	Mensual	Informe de dos páginas	Correo y ARB	Arquitecto líder
COM-05	Sesiones de trabajo con áreas	Levantamiento y validación	G2, G3, G4	Semanal durante el levantamiento	Acta de trabajo	Reunión en el servicio	Arquitectos de dominio
COM-06	Taller de validación	Validación del escenario EB-01 y procesos objetivo	G1, G2	En las semanas 6 y 11	Presentación y acta	Auditorio	Arquitecto de negocio
COM-07	Boletín "Avanzamos"	Logros, próximos pasos, cómo participar	G2, G3, G4	Mensual	Boletín de una página	Correo, intranet, mural	Equipo de arquitectura
COM-08	Oficio y reunión con entes sectoriales	Requisitos de interoperabilidad y reporte	G5	En las semanas 4, 13 y 20, y cuando se requiera	Oficio y acta de reunión	Mesa de partes y reunión técnica	Dirección Ejecutiva
COM-09	Información a pacientes	Mejoras en curso y protección de datos	G6	Al inicio y en cada hito con impacto visible	Afiche y aviso	Salas de espera	Equipo de arquitectura con Imagen Institucional
COM-10	Encuesta a pacientes	Percepción de tiempos y trato	G6	En las semanas 10 y 22	Encuesta anónima	Admisión y consultorios	Arquitecto de negocio
COM-11	Solicitud de información a proveedores	Datos técnicos de sistemas e infraestructura	G7	Semana 11	Carta formal	Correo y mesa de partes	Arquitecto de aplicaciones y tecnología
COM-12	Notificación de cambio aprobado	Decisión sobre una solicitud de cambio	Solicitante e interesados afectados	Por cada cambio aprobado	Notificación	Correo e intranet	Secretario del ARB
COM-13	Comunicación de cierre de fase	Entregables aprobados y siguiente fase	G1 a G4	En cada hito H1 a H8	Comunicado breve	Correo, intranet, boletín	Arquitecto líder
COM-14	Informe de cierre del ciclo	Resultados, lecciones aprendidas, siguiente iteración	G1 y todos los grupos internos	Semana 24	Informe y presentación	Auditorio y Repositorio	Patrocinador y arquitecto líder

7. Distribución de entregables por grupo de interesados

La siguiente matriz indica qué entregables recibe cada grupo y con qué acción. A significa aprobar, R revisar y observar, V validar el contenido de su ámbito, I informarse mediante un resumen y vacío indica que no lo recibe.

Tabla 12
Matriz de distribución de entregables

Entregable	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
A-01 Visión de la Arquitectura	A	V	I	R	I		
A-02 Declaración de Trabajo	A	I		R			
A-03 Plan de Comunicaciones	A	I	I	I			
A-04 Evaluación de Capacidades	A	I	I	R			
A-05 Definición de la Arquitectura v0.1	A	I		R			
B-01 y B-02 Arquitectura y requisitos de negocio	A	V	V	I			
C-01 Arquitectura de datos	A	V		R	I		
C-02 Arquitectura de aplicaciones	A	V	V	R	I		I
C-03 Requisitos de sistemas de información	A	V	V	R			
TEC-01 y TEC-02 Arquitectura tecnológica	A			V			I
E-01 y E-02 Hoja de ruta y estrategia de migración	A	I	I	R	I		
F-01 Plan de implementación y migración	A	I	I	R	I	I	
G-01 a G-03 y H-01 Gobierno de la implementación	A			R			I

Nota. Los pacientes (G6) reciben solo mensajes derivados del plan de migración que afecten su atención, mediante los canales de la Tabla 10. Los entes sectoriales (G5) reciben resúmenes por oficio, no los documentos internos completos.

8. Calendario de comunicaciones

El calendario está sincronizado con el cronograma unificado (A-01, Tabla 38) y con los hitos de la Declaración de Trabajo (A-02, Tabla 23). Reemplaza el calendario de la versión 1.0, que ubicaba la aprobación de la Declaración en el Mes 3.

Tabla 13

Calendario de comunicaciones por semana

Semana	Fase	Comunicaciones	Grupos
1	A	Convocatoria a la sesión de instalación del ARB; designación de enlaces	G1
2	A	Instalación del ARB (COM-02); lanzamiento del proyecto (COM-01); afiche inicial para pacientes (COM-09)	G1 a G4, G6
3 a 4	A	Entrevistas a actores clave; oficio de presentación del proyecto a la DIRESA y al Gobierno Regional (COM-08)	G1, G2, G5
5	A	Sesiones de trabajo para el escenario EB-01 (COM-05); primer boletín (COM-07)	G2, G3, G4
6	A	Taller de validación del escenario EB-01 (COM-06); sesión del ARB	G1, G2
7	A	Sesión del ARB: revisión de A-01 a A-05	G1
8	A	Firma de la Declaración; comunicado de cierre de la Fase A (COM-13)	G1 a G4
9 a 10	B	Sesiones de levantamiento del proceso actual; medición de tiempos; primera encuesta a pacientes (COM-10)	G2, G3, G6
11	B	Taller de validación del proceso objetivo (COM-06); solicitud de información a proveedores (COM-11)	G1, G2, G7
12	B	Sesión del ARB: arquitectura de negocio (hito H2); comunicado de cierre (COM-13)	G1 a G4
13	C y D	Reunión técnica con la DIRESA y el MINSA sobre interoperabilidad (COM-08); sesiones con la OSI	G4, G5
14	C y D	Validación del modelo de datos con personal clínico (COM-05)	G2, G4
15	C	Sesión del ARB: datos y aplicaciones (hito H3)	G1
16	D	Sesión del ARB: tecnología (hito H4); boletín	G1 a G4
17 a 18	E	Revisión de paquetes de trabajo con la Dirección; sesión del ARB (hito H5)	G1, G4
19	F	Presentación de la priorización de la hoja de ruta	G1, G2
20	F	Sesión del ARB (hito H6); oficio a entes sectoriales con el resumen del plan (COM-08)	G1, G5
21 a 22	G	Presentación del modelo de gobierno a la OSI; segunda encuesta a pacientes (COM-10)	G4, G6
23	G	Sesión del ARB (hito H7)	G1
24	Cierre	Informe de cierre del ciclo (COM-14); afiche con próximos pasos para pacientes (COM-09)	Todos

Nota. Además de lo indicado, durante las 24 semanas se mantienen las comunicaciones recurrentes: Comité de Seguimiento semanal (COM-03), sesiones del ARB quincenales (COM-02), informe mensual (COM-04) y boletín mensual (COM-07).

9. Retroalimentación y gestión de preocupaciones

La comunicación es de doble vía: las preguntas, observaciones y preocupaciones de los interesados son una fuente principal de requisitos. Por ello, este procedimiento conecta la retroalimentación con la Gestión de Requisitos y con el procedimiento de cambio de alcance de la Declaración de Trabajo (A-02, sección 9).

9.1 Vías de entrada

1. Correo del proyecto (architecture@hospitaltingomaria.gob.pe).
2. Observaciones en sesiones de trabajo, talleres y sesiones del ARB, registradas en acta.
3. Comunicaciones a través del enlace clínico y del enlace de la OSI.
4. Oficios de entes externos.
5. Encuestas a pacientes, buzón de sugerencias y libro de reclamaciones (solo comentarios relacionados con los procesos incluidos en el alcance).

9.2 Procedimiento

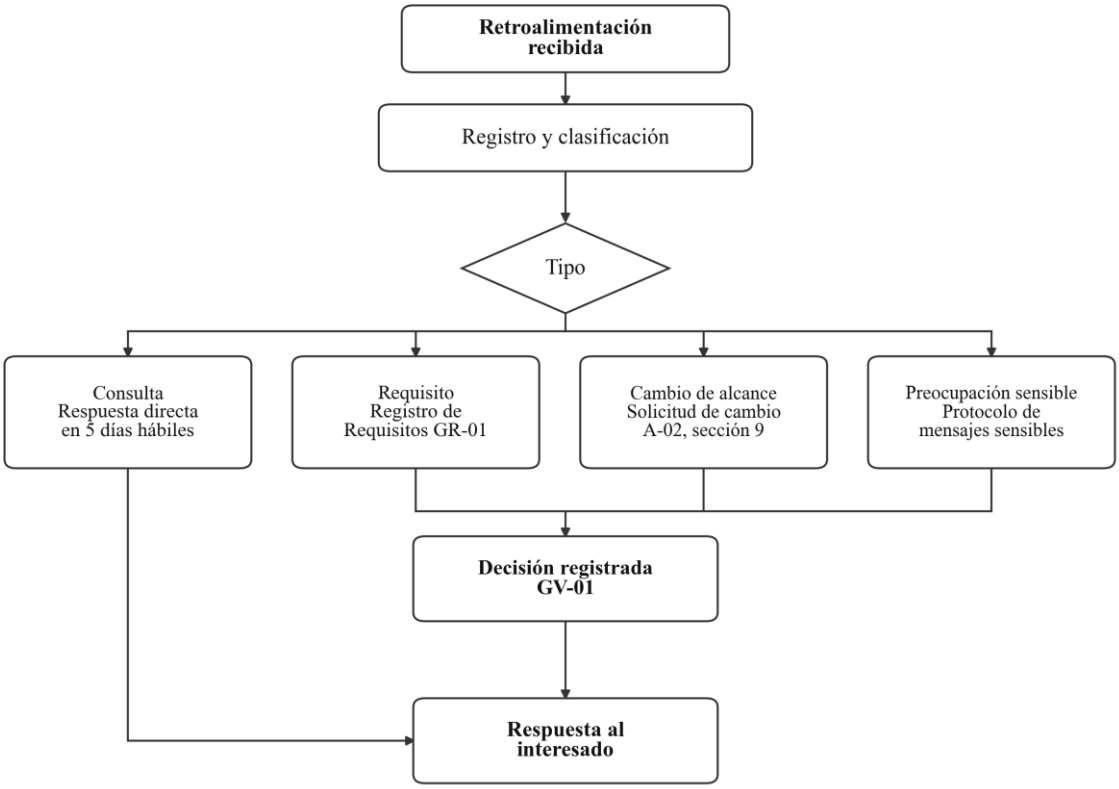


Figura 1
Flujo de tratamiento de la retroalimentación

Nota. GR-01 es el Registro de Requisitos de Arquitectura y GV-01 el Registro de Decisiones de Arquitectura (A-02, Tabla 18).

Tabla 14
Pasos del tratamiento de la retroalimentación

Paso	Actividad	Responsable	Plazo
1	Registrar la retroalimentación con fecha, origen, canal y contenido	Secretario del ARB	2 días hábiles
2	Clasificarla como consulta, requisito, solicitud de cambio o preocupación sensible	Arquitecto líder	2 días hábiles
3	Responder consultas directamente	Arquitecto de dominio correspondiente	5 días hábiles
4	Registrar los requisitos en GR-01 con trazabilidad a metas y principios	Arquitecto de dominio	5 días hábiles
5	Tramitar las solicitudes de cambio según A-02, sección 9	Secretario del ARB	Según el nivel del cambio
6	Informar al interesado qué se decidió y por qué	Secretario del ARB	2 días hábiles después de la decisión
7	Si la decisión afecta a un principio, comunicarla a toda la organización	Arquitecto líder	En el siguiente boletín

10. Protocolo para mensajes sensibles

Algunos temas pueden generar temor, rumores o daño a la imagen del hospital si se comunican mal. El protocolo define quién habla, cuándo y con qué mensaje.

Tabla 15
Situaciones sensibles y respuesta de comunicación

Situación	Riesgo si no se atiende	Respuesta	Vocero
Rumor de que el sistema reemplazará personal	Resistencia del personal administrativo y clínico	Mensaje directo en reunión de área: el objetivo es reducir trámites repetidos, no puestos; las funciones que cambien irán acompañadas de capacitación	Patrocinador o Director(a) Asistencial
Temor del personal clínico a mayor carga de registro	Rechazo a validar procesos	Demostración del proceso objetivo con casos reales; compromiso de pruebas de usabilidad antes de cualquier implantación (PA-05)	Enlace clínico y arquitecto de negocio
Percepción de control o vigilancia por la auditoría de accesos	Desconfianza hacia el sistema	Explicar que la auditoría protege al paciente y también al profesional ante acusaciones infundadas	Director(a) Asistencial
Incidente con información del proyecto o filtración de datos	Daño a la confianza y responsabilidad legal	Activar el procedimiento institucional de incidentes; comunicación única desde la Dirección; ningún miembro del equipo declara por su cuenta	Patrocinador
Retrasos en decisiones sectoriales sobre interoperabilidad	Pérdida de credibilidad del proyecto	Informar con transparencia que esa parte depende de entes externos y mostrar el avance del resto	Arquitecto líder
Consulta de medios de comunicación	Mensajes contradictorios en público	Solo la Dirección Ejecutiva declara, con base en el mensaje central (sección 4.1)	Patrocinador

11. Factores críticos de éxito e indicadores de efectividad

11.1 Factores críticos de éxito

TOGAF pide identificar los factores críticos de éxito (FCE) de la comunicación, es decir, las condiciones sin las cuales el plan fracasa (The Open Group, 2011, cap. 36).

Tabla 16
Factores críticos de éxito de la comunicación

Código	Factor crítico de éxito	Cómo se asegura
FCE-01	El patrocinador respalda visiblemente el proyecto	Participa en el lanzamiento, preside el ARB y firma los comunicados clave
FCE-02	El personal clínico cuenta con tiempo protegido para participar	Resolución de la Dirección Asistencial que asigna horas al enlace clínico y a las sesiones
FCE-03	Los mensajes son coherentes y honestos	Todo comunicado se basa en los entregables aprobados y en la Tabla 9
FCE-04	La retroalimentación recibe respuesta	Plazos de la Tabla 14 controlados en el Comité de Seguimiento
FCE-05	Los entes sectoriales se involucran desde el inicio	Oficio de presentación en la semana 4 y reunión técnica en la semana 13

11.2 Indicadores de efectividad

Tabla 17
Indicadores para medir la efectividad de la comunicación

Código	Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia
IC-COM-01	Asistencia a sesiones de trabajo y talleres	Asistentes ÷ convocados × 100	80 % o más	Mensual
IC-COM-02	Quórum del ARB	Sesiones con quórum ÷ sesiones programadas × 100	100 %	Mensual
IC-COM-03	Oportunidad de las actas	Actas distribuidas en 3 días hábiles ÷ total de actas × 100	90 % o más	Mensual
IC-COM-04	Respuesta a la retroalimentación	Entradas respondidas en plazo ÷ total de entradas × 100	90 % o más	Mensual
IC-COM-05	Conocimiento del proyecto en el personal	Personal encuestado que conoce el propósito del proyecto ÷ total encuestado × 100	70 % o más al cierre de la Fase B	Semanas 12 y 24
IC-COM-06	Entregables aprobados en primera revisión	Entregables aprobados sin rechazo ÷ entregables presentados × 100	80 % o más	Por hito

Nota. Los resultados se reportan en el informe mensual de avance (COM-04). Si un indicador queda por debajo de su meta durante dos meses seguidos, el Comité de Seguimiento propone ajustes al plan.

12. Roles y responsabilidades de comunicación

Tabla 18
Responsabilidades de comunicación por rol

Rol	Responsabilidad en la comunicación
Patrocinador	Vocero institucional; firma el lanzamiento, los oficios a entes externos y los mensajes sensibles
Arquitecto líder	Responsable general del plan; prepara informes, comunicados de cierre de fase y el informe final
Secretario del ARB	Convoca, elabora y distribuye actas; registra la retroalimentación y las decisiones
Arquitectos de dominio	Conducen sesiones de trabajo y talleres; responden consultas técnicas
Enlace clínico	Difunde la información entre el personal médico y de enfermería; canaliza sus preocupaciones
Enlace de la OSI	Difunde la información técnica en la OSI; habilita los canales digitales
Oficina de Recursos Humanos	Coordina los mensajes relacionados con capacitación y funciones del personal
Administrador del Repositorio	Publica los entregables aprobados y mantiene el historial de versiones

13. Riesgos de comunicación

Los riesgos se valoran antes y después de aplicar la mitigación, siguiendo el enfoque de gestión de riesgos de TOGAF (The Open Group, 2011, cap. 31).

Tabla 19
Registro de riesgos de comunicación

Código	Riesgo	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-C-01	El personal clínico no participa en las sesiones por la carga asistencial	Alto	Tiempo protegido (FCE-02); sesiones de 45 minutos en el propio servicio	Medio	Dirección Asistencial
R-C-02	Rumores sobre reemplazo de personal generan resistencia	Medio	Protocolo de mensajes sensibles (sección 10); mensaje temprano en el lanzamiento	Bajo	Patrocinador
R-C-03	Mensajes contradictorios entre canales o voceros	Medio	Mensaje central único; revisión de comunicados por el arquitecto líder	Bajo	Arquitecto líder
R-C-04	La retroalimentación no se registra y se pierden requisitos	Medio	Registro desde la primera sesión; control de plazos en el Comité	Bajo	Secretario del ARB
R-C-05	Los entes sectoriales no responden a tiempo	Medio	Oficio temprano; seguimiento telefónico y reunión técnica	Medio	Dirección Ejecutiva
R-C-06	Expectativas excesivas en pacientes y personal	Medio	Aplicar la columna "lo que no se debe prometer" de la Tabla 9	Bajo	Arquitecto líder
R-C-07	Fallas de la intranet o del correo institucional	Bajo	Respaldo con periódico mural, impresos y comunicación por enlaces	Bajo	OSI

14. Supuestos y restricciones

14.1 Supuestos

Tabla 20
Supuestos del plan

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-C-01	El personal del hospital tiene acceso al correo institucional o a la intranet	OSI	Semana 2	Pendiente
S-C-02	Las jefaturas médicas y administrativas disponen de tiempo para las sesiones de trabajo	Dirección Asistencial y Dirección de Administración	Semana 4	Pendiente
S-C-03	El hospital cuenta con un auditorio y espacios en salas de espera para afiches	Dirección de Administración	Semana 2	Pendiente
S-C-04	La Dirección Ejecutiva acepta actuar como vocero institucional del proyecto	Dirección Ejecutiva	Semana 2	Pendiente

14.2 Restricciones

Tabla 21
Restricciones del plan

Código	Restricción	Ámbito
CN-C-01	Ninguna comunicación incluye datos personales de pacientes (Ley N.° 29733, 2011)	Todos los canales
CN-C-02	Las sesiones del ARB solo son válidas con quórum	Gobierno
CN-C-03	Las actividades con personal clínico no pueden interrumpir la atención	Operación clínica
CN-C-04	La comunicación con entes externos se realiza solo por canales formales y con firma de la Dirección	Comunicación externa

15. Conclusiones

1. El plan organiza a los dieciocho interesados en siete grupos con necesidades de comunicación distintas, lo que permite dirigir a cada uno el mensaje, el canal y el momento adecuados.
2. Los mensajes clave se vinculan con objetivos e indicadores de la Visión de la Arquitectura y definen expresamente lo que no debe prometerse, para proteger la credibilidad del proyecto.
3. El calendario de 24 semanas está sincronizado con los hitos de la Declaración de Trabajo, de modo que cada aprobación vaya precedida de la validación y seguida de la comunicación correspondiente.
4. La retroalimentación se conecta con la Gestión de Requisitos y con el procedimiento de cambio, de forma que ninguna preocupación se pierda.

5. La efectividad del plan se medirá con seis indicadores, y sus riesgos principales, como la falta de tiempo del personal clínico y los rumores sobre reemplazo de personal, cuentan con mitigaciones concretas.

16. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

Nota. Al exportar el documento a Word, la lista de referencias debe llevar sangría francesa de 1,27 cm, conforme a APA 7.

17. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura (*Architecture Review Board*)
COM	Código de comunicación de la matriz
DIRESA	Dirección Regional de Salud
FCE	Factor crítico de éxito
MINSA	Ministerio de Salud
OSI	Oficina de Sistemas y Información del hospital
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
SIS	Seguro Integral de Salud
SUSALUD	Superintendencia Nacional de Salud

Apéndice B. Modelo de acta de sesión

Tabla B1
Contenido mínimo del acta de sesión

Campo	Contenido
Datos de la sesión	Número, fecha, hora, lugar y tipo de sesión
Asistentes	Nombre, cargo y grupo; verificación de quórum (si es sesión del ARB)
Agenda	Temas tratados
Acuerdos	Decisiones tomadas, con responsable y plazo
Observaciones	Observaciones recibidas, clasificadas como bloqueantes o no bloqueantes
Retroalimentación registrada	Códigos asignados en GR-01 o GV-01
Firmas	Presidente y secretario, o responsable de la sesión de trabajo

Apéndice C. Modelo de encuesta breve para pacientes

Tabla C1
Preguntas de la encuesta anónima a pacientes

N.°	Pregunta	Tipo de respuesta
1	¿Cuánto tiempo esperó desde que llegó hasta que lo atendió el médico?	Menos de 30 min / 30 a 60 min / 1 a 2 horas / Más de 2 horas
2	¿Tuvo que dar sus datos personales más de una vez durante su atención?	Sí / No
3	¿El médico tenía a la vista sus resultados o atenciones anteriores?	Sí / No / No sé
4	¿Qué tan satisfecho está con su atención de hoy?	Escala de 1 a 5
5	¿Qué mejoraría de su atención?	Respuesta abierta

Nota. La encuesta no solicita nombre, DNI ni datos de salud, en cumplimiento de la restricción CN-C-01.

18. Hoja de control de aprobaciones

Este documento surte efecto cuando es aprobado por el ARB.

Tabla 22
Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Presidente del ARB (Director[a] Ejecutivo[a])				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos				